

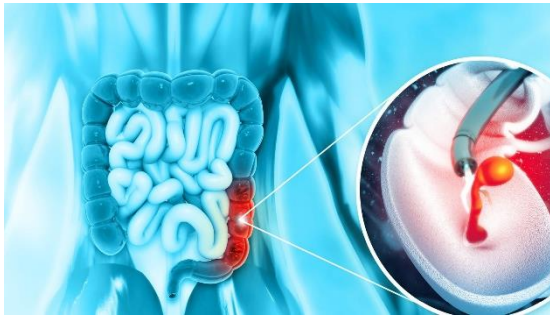


Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غربالگری سرطان روده بزرگ

سرطان روده یکی از قابل پیشگیری ترین سرطان هاست؛ حدود ۷۵٪ موارد با سبک زندگی سالم و غربالگری منظم قابل پیشگیری هستند.



بیشتر دانشمندان معتقدند که برخی عوامل بر خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ تأثیر می گذارند. بعضی از این عوامل قابل تغییر هستند و بعضی نه. انتخاب یک سبک زندگی سالم می تواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ و بسیاری بیماری های دیگر را کاهش دهد. و فراموش نکنید که توصیه های غربالگری را دنبال کنید.

نکات پیشگیری

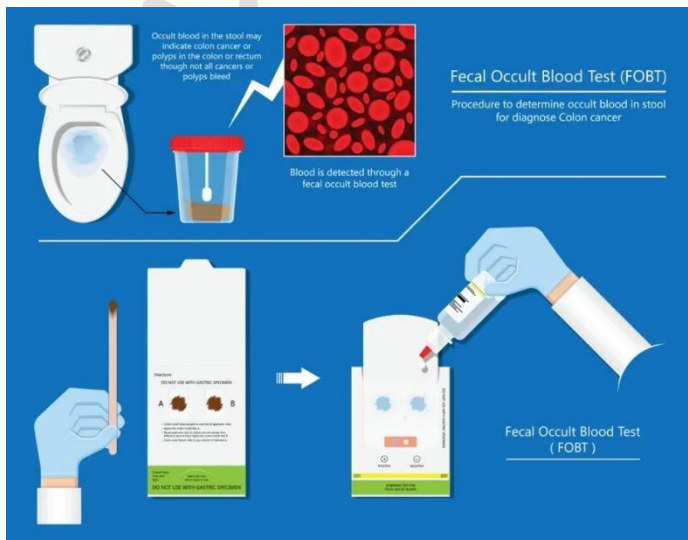
چیزهایی که می توانی تغییر دهی:

✓ غربالگری شوید

غربالگری یکی از مهم ترین راهها برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ است. آزمایش های غربالگری می توانند به پیدا کردن و برداشتن رشدایی به نام پولیپها قبل از تبدیل شدن به سرطان کمک کنند. سن شروع غربالگری ۴۵-۵۰ سال است. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ یا سایر عوامل خطر مهم دارند، ممکن است از سنین پایین تر شروع به آزمایش کنند و بیشتر آزمایش شوند.

تعداد زیادی آزمایش مؤثر برای سرطان روده بزرگ وجود دارد. یک پزشک می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند. گزینه های توصیه شده شامل:

- آزمایش خون مخفی در مدفوع (FOBT) هر سال
- آزمایش ایمنوشیمیایی مدفوع (FIT) هر سال
- کولونوسکوپی - هر ۱۰ سال یک بار
- سیگموئیدوسکوپی انعطاف پذیر - هر پنج سال یکبار طبق نظر متخصص
- آزمایش DNA مدفوع - هر سه سال یکبار





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ فعالیت بدنی – هدف حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی در روز باشد

فعالیت بدنی علاوه بر کاهش خطر سرطان روده بزرگ، در پیشگیری از سرطان سینه، بیماری‌های قلبی، دیابت و سکنه هم نقش دارد. فعالیت‌هایی را که دوست دارید انتخاب کنید و آن‌ها را در روال روزانه‌تان بگنجانید. ده دقیقه اینجا و آنجا در طول روز می‌تواند به سرعت به سی دقیقه‌ای که نیاز دارید اضافه شود. به جای آسانسور از پله‌ها استفاده کنید. با یک دوست قدم بزنید.

✓ وزن سالم را حفظ کنید

افرادی که وزن سالم خود را حفظ می‌کنند، خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می‌دهند. و هم چنین خطر چند سرطان دیگر (سینه، کلیه، لوزالمعده و رحم) را کاهش می‌دهد. برای کنترل وزن: فعالیت بدنی منظم داشته باشید. رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات و غلات کامل مصرف کنید. غذا را آهسته و در وعده‌های کوچک‌تر بخورید. در صورت دشواری، از پزشک یا مشاور تغذیه کمک بگیرید.

✓ غلات کامل زیادی بخورید – هدف‌تان ۳ وعده یا بیشتر در روز باشد.

رژیم غذایی غنی از غلات کامل می‌تواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. غلات کامل منبع عالی فیبر و سایر مواد مغذی مهم هستند. غذاهای غلاتی را انتخاب کنید که "کامل" یا "غلات کامل" به عنوان اولین ماده در برچسب غذایی داشته باشند. انتخاب‌های آسان شامل: نان ۱۰۰٪ گندم کامل، غلات جو دوسر تفت داده شده، برنج قهوه‌ای، و جو دوسر قدیمی. سعی کنید هر روز حداقل سه وعده غلات کامل مصرف کنید. این معادل حدود ۳ برش نان ۱۰۰٪ گندم کامل یا یک و نیم فنجان برنج قهوه‌ای پخته شده است.

✓ مصرف گوشت‌های فرآوری‌شده را محدود کنید – هدف‌تان کمتر از ۳ وعده در هفته باشد.

خوردن بیش از حد گوشت قرمز – مانند استیک، همبرگر و گوشت خوک – خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را افزایش می‌دهد. و گوشت‌های فرآوری شده – مانند ژامبون، بیکن، سوسیس و کالباس – خطر را حتی بیشتر افزایش می‌دهند. سعی کنید کمتر از سه وعده در هفته مصرف کنید. کمتر حتی بهتر است.

✓ سیگار نکشید:

ترک سیگار بودن اولین و مهم‌ترین کاری است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید. سیگار کشیدن خطر ابتلا به ۱۵ نوع سرطان، از جمله سرطان روده بزرگ را افزایش می‌دهد. ترک سیگار در هر سنی باعث بهبود سلامت می‌شود.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ یک مولتی ویتامین مصرف کنید.

یک مولتی ویتامین روزانه یک بیمه تغذیه‌ای خوب است که می‌تواند در برابر سرطان روده بزرگ نیز محافظت کند. علاوه بر کلسیم و ویتامین D، مولتی ویتامین‌ها حاوی فولات هستند که در مطالعات متعدد نشان داده شده است که خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می‌دهند. از ویتامین‌های دوز بالا پرهیز کنید. یک مولتی ویتامین استاندارد بهترین انتخاب است.

✓ کلسیم و ویتامین D کافی دریافت کنید

شواهد خوبی وجود دارد که دریافت کافی کلسیم و ویتامین D می‌تواند به پیشگیری از سرطان روده بزرگ کمک کند. به دنبال ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی گرم کلسیم در روز و حدود ۱۰۰۰ واحد بین‌المللی (IU) ویتامین D در روز باشید.

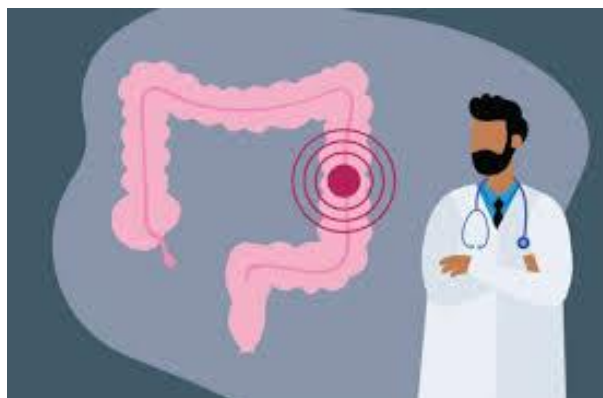
محصولات لبنی، مانند شیر بدون چربی یا کم‌چرب و ماست، بهترین منابع کلسیم هستند، اما می‌توانید کلسیم مورد نیاز خود را با خوردن غذاهای غنی‌شده با کلسیم (مانند آب‌پرتقال غنی‌شده و بیشتر غلات صبحانه) یا مصرف مکمل کلسیم هر روز به دست آورید. غذاهای غیر لبنی دیگری نیز سرشار از کلسیم هستند، مانند حبوبات (لوبیا سیاه، لوبیا دریایی، سویا)، ماهی کنسرو شده (ساردین یا سالمون کامل با استخوان‌ها)، آجیل (بادام و فندق برزیلی) و سبزیجات (اسفناج و خردل).

منابع خوب ویتامین D شامل تخم‌مرغ، ماهی‌های چرب (مانند تن و سالمون)، محصولات لبنی غنی‌شده و نور مستقیم خورشید هستند (اما از مقدار زیاد آن پرهیز کنید - کمی از آن کافی است).

یک مولتی ویتامین یک بیمه تغذیه عالی است، اما هرگز نباید جایگزین غذای واقعی یا رژیم غذایی سالم شود.

✓ اقداماتی برای پیشگیری/کنترل دیابت انجام دهید

افراد مبتلا به دیابت خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان روده بزرگ دارند. اگر دیابت دارید، بسیار مهم است که به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید. سیگار نکشیدن، فعال ماندن، خوردن یک رژیم غذایی سالم و حفظ وزن سالم می‌تواند به کنترل یا پیشگیری از دیابت نوع ۲ کمک کند. بسیاری از افراد همچنین به دارو یا انسولین نیاز دارند تا قند خون خود را کنترل کنند.





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل تولیدمثلی:

➤ قرص‌های ضدبارداری. با پزشک درباره خطرات و مزایا صحبت کنید.

زنانی که به مدت حداقل ۵ سال از قرص‌های ضد بارداری استفاده می‌کنند، خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در آن‌ها کمتر است. هرچه مدت بیشتری یک زن قرص ضد بارداری مصرف کند، خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در او کمتر می‌شود. یک توضیح ممکن این است که قرص‌های ضد بارداری سطح برخی از مواد شیمیایی گوارشی در بدن را کاهش می‌دهند. سطوح بالای این مواد شیمیایی ممکن است باعث شوند سلول‌های روده بزرگ سرطانی شوند.

قرص‌های ضد بارداری می‌توانند تأثیرات مثبت و منفی بر سلامت زنان داشته باشند. اگر به مدت حداقل ۵ سال مصرف شوند، قرص‌های ضد بارداری می‌توانند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، سرطان رحم و سرطان تخمدان را در زنان کاهش دهند. با این حال، در حین مصرف آن‌ها، خطر ابتلا به سرطان سینه، حمله قلبی و سکته مغزی در زنان افزایش می‌یابد. برای برخی از زنان، آن‌ها می‌توانند عوارض جانبی مانند تهوع و استفراغ ایجاد کنند. به طور عمیق با یک پزشک درباره خطرات و مزایای آن‌ها صحبت کنید. با هم می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا این درمان‌ها برای شما مناسب هستند یا نه.

➤ هورمون درمانی یائسگی. با پزشک درباره خطرات و مزایا صحبت کنید.

هورمون درمانی یائسگی می‌تواند به کاهش علائم یائسگی، مانند گرگرفتگی و خشکی واژن کمک کند. زنانی که به مدت حداقل ۵ سال از درمان هورمونی یائسگی استفاده می‌کنند، خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ کمتری دارند. اگرچه دانشمندان مطمئن نیستند چرا، ممکن است که درمان هورمونی یائسگی سطح برخی از مواد شیمیایی مورد نیاز برای هضم را کاهش دهد. سطوح بالای این مواد شیمیایی ممکن است باعث شوند که سلول‌های روده بزرگ سرطانی شوند.

هورمون درمانی یائسگی می‌تواند هم اثرات مثبت و هم منفی بر سلامت زنان داشته باشد. اگر زنان تصمیم به استفاده از درمان هورمونی برای کاهش علائم یائسگی بگیرند، باید برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باشد - نه بیشتر از ۱ تا ۳ سال. و نباید به طور طولانی مدت با هدف کاهش خطر بیماری‌هایی مانند بیماری قلبی یا از دست دادن استخوان (پوکی استخوان) مصرف شوند. با پزشک درباره خطرات و مزایای درمان هورمونی یائسگی صحبت کنید.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل غیر قابل تغییر:

▪ سن

خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ با افزایش سن افزایش می‌یابد. بیشتر موارد در افراد بالای ۵۰ سال تشخیص داده می‌شود. میانگین سنی که این بیماری تشخیص داده می‌شود ۶۸ سال است.

▪ قد

افراد قد بلند خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان روده بزرگ دارند. محققان دقیقاً نمی‌دانند چرا، اما ممکن است به این دلیل باشد که افراد قد بلند بیشتر رشد می‌کنند. برخی از همان هورمون‌ها و عوامل دیگری که باعث رشد افراد می‌شوند، ممکن است شانس تبدیل شدن سلول‌های تقسیم‌شونده به سلول‌های غیرطبیعی و سرطانی را نیز افزایش دهند.

▪ بیماری التهابی روده

بیماری التهابی روده (IBD) ناشی از تغییرات غیرطبیعی در دستگاه گوارش است. دو نوع اصلی آن بیماری کرون و کولیت اولسراتیو هستند.

افرادی که به مدت ۱۰ سال یا بیشتر به بیماری التهابی روده مبتلا هستند، خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در آنها بیشتر است. این احتمالاً به این دلیل است که بیماری التهابی روده باعث می‌شود سلول‌های روده بزرگ خیلی سریع رشد و تقسیم شوند. اگر در طول این فرآیند آسیب به DNA رخ دهد، ممکن است به سرطان روده بزرگ منجر شود.

▪ سابقه خانوادگی

افرادی که یکی از بستگان نزدیک (مادر، پدر، برادر یا خواهر) آنها به سرطان روده بزرگ مبتلا است، خطر بیشتری برای ابتلا به این بیماری دارند. این به این دلیل است که برخی از سرطان روده بزرگ به جهش‌ها (تغییرات) در ساختار ژنتیکی (DNA) سلول‌های بدن مرتبط است که می‌تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

افرادی که سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ دارند ممکن است نیاز به انجام آزمایش‌های غربالگری برای این بیماری زودتر و بیشتر از سایرین داشته باشند.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

فراموش نکنید که غربالگری سرطان روده بزرگ را انجام دهید.

نکات غربالگری غربالگری به تشخیص زودهنگام کمک می کند، زمانی که بیماری قابل درمان تر

است.

تعدادی از آزمایش های غربالگری مؤثر برای سرطان روده بزرگ وجود دارد. اینکه کدام آزمایش را انجام دهید بستگی به ترجیحات شخصی و سابقه پزشکی شما دارد. یک پزشک می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند. سن شروع غربالگری سرطان روده ۴۵-۵۰ سال است و بیشتر مردم از سن ۴۵ سالگی شروع به آزمایش می کنند. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ یا سایر عوامل خطر مهم دارند، ممکن است از سن پایین تر شروع به آزمایش کنند و بیشتر آزمایش شوند.

گزینه های غربالگری توصیه شده:

- آزمایش خون مخفی مدفوع (FOBT) - هر سال
- آزمایش ایمنی شناسی مدفوع (FIT) - هر سال
- کولونوسکوپی - هر ۱۰ سال یک بار
- سیگموئیدوسکوپی انعطاف پذیر - هر پنج سال
- کولونوسکوپی مجازی - هر پنج سال
- آزمایش DNA مدفوع - هر سه سال

احساس درد و حساسیت در قسمت
تحتانی شکم



خون در مدفوع



کاهش وزن بدون دلیل مشخص



اسهال، یبوست یا سایر تغییرات
در عادات روده



مدفوع باریک



علائم سرطان روده بزرگ



درمانگاه



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش یا کاهش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه که درباره سرطان روده بزرگ می دانیم،

این موارد هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند

چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

شما دیابت یا قند خون بالا دارید.

شما قدبلند هستید.

شما سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ دارید.

شما به مدت ۱۰ سال یا بیشتر به بیماری التهابی روده مبتلا بوده اید.

شما به طور منظم برای ۱۲ سال یا بیشتر مولتی ویتامین مصرف نکرده اید.

شما هر روز یا تقریباً هر روز مولتی ویتامین یا مکمل ویتامین D مصرف نمی کنید.

چه چیزی خطر شما را کاهش می دهد:

هرگز سیگار نکشیده اید.

شما اضافه وزن ندارید.

شما در بیشتر روزها ۳ یا بیشتر وعده غلات کامل می خورید.

عدم مصرف الکل

شما حداقل ۳۰ دقیقه در روز فعالیت بدنی دارید.

شما به مدت ۶ سال یا بیشتر، هفته ای ۲ بار یا بیشتر آسپرین مصرف کرده اید.

شما بیشتر از ۲ وعده گوشت فرآوری شده در هفته نمی خورید.

شما در بیشتر روزها مکمل کلسیم مصرف می کنید.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

هوشمند سلامت

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه من به من می‌شود؟	
احتمال	ریسک بالا (High Risk)
مقایسه	سابقه خانوادگی افراد درجه اول با سرطان کولورکتال یا پولیپ پیشرفته (تشخیص داده شده در سن پایین)،
برای دارد	پولیپ پیشرفته شخصی بالا (مثلاً adenoma بزرگ، چند پولیپ)، سندرم‌های ژنتیکی مثل Lynch، FAP. سابقه بیماری التهابی روده مزمن با مدت زمان طولانی، سابقه پرتودرمانی شکمی/لگنی قبلی
ریسک متوسط / کم (Average / Low Risk)	افراد بدون سابقه خانوادگی برجسته سرطان کولورکتال، بدون سابقه پولیپ‌های پیشرفته یا adenoma، بدون سندرم ژنتیکی شناخته‌شده، بدون التهاب روده شدید یا بیماری التهابی مزمن (IBD)
• علم همواره در حال پیشرفت است و ممکن است عوامل جدیدی در آینده شناخته شوند یا وزن عوامل فعلی تغییر کند.	

چرا باید به آن توجه کرد؟

توصیه‌ها



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها برای افراد با ریسک متوسط / کم

سبک زندگی سالم:

فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی با مقدار زیاد میوه، سبزیجات، غلات کامل، پرهیز از مصرف زیاد گوشت قرمز و فرآوری‌شده، کاهش مصرف الکل، کنترل وزن بدن، مصرف کافی ویتامین D، کلسیم و فولات در حد توصیه‌شده

غربالگری منظم:

- شروع غربالگری: افراد بدون ریسک بالا باید از سن ۴۵ سالگی شروع به غربالگری منظم بکنند.
- فرکانس غربالگری و گزینه‌ها: گزینه‌های قابل قبول شامل تست‌های مدفوعی حساس (FIT یا FOBT)، کالونوسکوپی هر ۱۰ سال، یا معاینه تصویر برداری نظیر سیگموئیدوسکوپی انعطاف‌پذیر هر ۵ سال یا ترکیبی از تست مدفوعی و معاینه است.
- توقف غربالگری: برای افراد سالم با عمر پیش‌بینی‌شده کمتر از ۱۰ سال یا بالای حدود ۷۵ سال، شروع یا ادامه غربالگری بر اساس وضعیت سلامتی عمومی و ترجیح فردی است.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

افراد ریسک بالا باید مراقبت بیش‌تری داشته باشند. طبق گایدلاین‌های به‌روز توصیه‌های زیر مطرح شده‌اند:

۱. ارزیابی ژنتیکی و مشاوره

اگر در خانواده سابقه سرطان کولورکتال باشد یا سندرم ژنتیکی مشکوک (مثلاً Lynch، FAP و غیره)، باید مشاوره ژنتیک انجام شود و بررسی جهش‌های مرتبط انجام پذیرد

۲. شروع زودتر برای غربالگری

افرادی که دارای ریسک فAMILIAL یا ژنتیکی بالا هستند معمولاً باید غربالگری را قبل از سن متوسط شروع کنند، مثلاً در سن ۴۰ سال یا حتی ۱۰ سال قبل از سن تشخیص یکی از اعضای خانواده، بسته به دستورالعمل.

۳. غربالگری با دفعات بیشتر و روش‌های دقیق‌تر:

- کالونوسکوپی به‌عنوان آزمون استاندارد برای افراد پرخطر، تکرار هر ۳-۵ سال بسته به نتایج پولیپ قبلی یا یافته‌ها.
- ممکن است استفاده از معاینات بیشتر یا تست‌های مکمل (مانند بررسی‌های ژنتیکی یا آزمایش‌های مدفوعی با حساسیت بالا) توصیه شود.

۴. سندرم‌های ژنتیکی خاص:

برای افرادی با سندرم‌هایی مثل Lynch syndrome، FAP، MUTYH-associated polyposis و سایر ژن‌های شناخته‌شده مرتبط، گایدلاین‌ها توصیه به شروع غربالگری از سنین کم‌تر (مثلاً نوجوانی یا اوایل بزرگسالی بسته به سندرم) و گاهی معاینات سالانه یا نیمه‌سالانه می‌کنند.

۵. توسعه و نظارت منظم:

اگر فردی قبلاً پولیپ داشته باشد یا کالونوسکوپی قبلی نشان داده باشد، نیاز است برنامه نظارت (surveillance) دقیق داشته باشد، نه فقط غربالگری معمولی.

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و ارزیابی

دقیق انجام شود.